

TEMA 65



TÉCNICAS EN TRABAJO SOCIAL: DE CONOCIMIENTO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERVENCIÓN Y DE EVALUACIÓN.

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS EN TRABAJO SOCIAL: FICHA SOCIAL, INFORME SOCIAL, ESCALAS DE VALORACIÓN SOCIAL Y PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
0.1.- Algunos conceptos. 0.2.- Criterios para la selección de las técnicas.	
1.- Técnicas en trabajo social.	
1.1.- Técnicas de conocimiento. 1.2.- Técnicas de diagnóstico. 1.3.- Técnicas de intervención. 1.4.- Técnicas de evaluación.	
2.- Instrumentos específicos en trabajo social.	
2.1.- Ficha social. 2.2.- Informe social. 2.3.- Historia social. 2.4.- Escalas de valoración social. 2.5.- Proyecto de intervención social.	

0.- INTRODUCCIÓN.

Las **técnicas** son los recursos de los que se vale una ciencia para conseguir unos fines determinados, así como, también son, la habilidad para usar esos recursos y esos procedimientos. El Trabajador Social comparte las técnicas con otras disciplinas sociales, si bien en la profesión algunas de ellas alcanzan una dimensión especial. Así pues, las técnicas que usamos en Trabajo Social provienen de otras ciencias como la Psicología, la Sociología, la Antropología, etc. Se diferencian de las de las empleadas en esas ciencias por la finalidad con que nosotros las utilizamos.

Las técnicas se sitúan a nivel de los hechos y permiten la aplicación del método, por medio de elementos prácticos, concretos y adaptados a un objetivo bien definido. En la profesión marcan el estilo de trabajo y son la eficacia de nuestro quehacer. Kisnerman dice que son **maneras o formas con las que se opera en una determinada situación y también que son medios para obtener determinados fines**.

Por tanto, se trata de la utilización consciente e intencionada de conocimientos, procedentes de la teoría, de la experiencia y de otras fuentes de información, que el Trabajador Social transforma en conductas mediante la relación que establece con el cliente.

- Las técnicas no son el camino- como es el método-, sino que son la manera de recorrer ese camino; los procedimientos que se han de seguir para conseguir llegar a una finalidad. Es un medio de lograr un fin, adaptado al género del problema y del fenómeno en cuestión.
- Todo instrumento puede ser utilizado con una técnica mejorable. En sentido material, es sinónimo de herramienta; en sentido inmaterial, habilidad o forma de estar; y en sentido amplio, las propias técnicas pueden ser consideradas como instrumentos para la realización del método y el método como instrumento para una acción eficaz respecto a unos objetivos.
- El método en T.S. puede definirse como una estructura sistemática de procedimientos, necesarios para obtener un resultado a través de un proceso de transformación de una realidad o situación concreta (M. Colomer). La finalidad del método es la obtención de unos resultados, la modificación o cambio de situaciones. En cambio, la metodología es la estructura básica de procedimiento que subyace en todo trabajo o acción social. Para Cristina de Robertis, es el conjunto organizado de principios en base a los cuales se plantea la comprensión y explicación de la realidad, como abordarla y transformarla.

Instrumentos, métodos y técnicas no serán útiles si no les sustenta una Política Social claramente determinada, unos recursos adjudicados a los programas y unas funciones concretas señaladas a los distintos profesionales que intervienen.

ALGUNOS CONCEPTOS.

Metodología.

El término **metodología** designa el modo en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas. En las ciencias sociales se aplica a la manera de realizar la investigación. La metodología es la estructura básica de procedimiento que subyace a la acción social. Son los principios básicos mediante los que se plantea la comprensión y la explicación de la realidad.

Por ejemplo, en la investigación social nos encontramos con dos metodologías para situarnos y comprender la realidad. La primera de ellas sería la metodología o enfoque cualitativo, la segunda el enfoque cuantitativo. También podemos hacer referencia a un enfoque mixto.

Metodología: enfoque desde el que nos acercamos a la realidad.

Método.

Tomamos la definición clásica de **Ander-Egg**, considerando el **método** como "el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar un determinado fin que puede ser material o conceptual". A diferencia de otras ciencias sociales, que se plantean finalidades más teóricas, la finalidad última del método en Trabajo Social es la transformación de la realidad social

Ejemplo: un método de conocimiento de la realidad social es el método de "encuesta". Desde esta perspectiva entendemos la encuesta como un procedimiento por el cuál recogemos información mediante un sistema de preguntas y respuestas (ya se realicen de forma oral, escrita …).

Método: procedimiento racional que el trabajo social sigue para estudiar y transformar su objeto de intervención.

Técnica.

Los métodos son los procedimientos generales o marcos de referencia. Por ello, se van a concretar en las **técnicas,** como procedimientos que los hacen operativos. Las técnicas se sitúan al nivel de los hechos y permiten la aplicación de los métodos por medio de elementos prácticos, concretos y adaptados al objeto de estudio. Las técnicas no son el camino –eso es el método-, sino la manera en que se recorre ese camino.

Ejemplo: una técnica del método de la encuesta sería el cuestionario.

Técnica: conjunto de procedimientos, recursos y medios puestos en práctica para obtener un resultado determinado.

Instrumento.

En sentido material, se refiere a una herramienta. En sentido inmaterial, a habilidades. Es un concepto difuso, ya que, las propias técnicas pueden ser consideradas como instrumentos para la realización del método, o el propio método puede ser considerado como un instrumento para desarrollar un trabajo social eficaz.

Instrumento: conjunto de diversos elementos combinados adecuadamente para que sirva con determinado objeto en el ejercicio de las artes y los oficios.

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS.

Actualmente en el Trabajo Social, en función de los principios que definimos para nuestra profesión, podemos plantear un conjunto de criterios para seleccionar las técnicas.

- **Adecuación:** hay que elegir la técnica que sea más adecuada a la realidad en la que vamos a intervenir.
- **Productividad:** está relacionada con la eficacia para alcanzar los objetivos buscados con el mínimo coste de recursos.
- **Participación:** se deben plantear técnicas que promuevan o posibiliten la participación de los ciudadanos, grupos, comunidades.

- **Globalidad:** las técnicas nos deben permitir acercamientos globales, integrales a la realidad en la que vamos a intervenir.

1.- TÉCNICAS EN TRABAJO SOCIAL.

Las técnicas más utilizadas en T.S. son las de **relación, las de investigación y las de acción**. Y entre todas ellas la entrevista, la observación y las de grupo.

A nivel individual, las más usadas son la entrevista y la observación. A nivel familiar y de pequeño grupo las charlas familiares, la observación y la entrevista. A nivel de grupo grande reuniones, asambleas, observación directa y documental, mesa redonda, etc. Y a nivel de comunidad reuniones, phillips 6.6, simposium, técnicas de comunicación masiva, etc.

A nivel metodológico podemos diferenciar diferentes técnicas en función del momento en el que se desarrollan:

- **En la investigación:** entrevista, observación y encuesta.
- **En el diagnóstico:** técnicas documentales, charlas, diagramas, técnicas estadísticas.
- **En la planificación:** reuniones de gabinete, charlas, técnicas de partes.
- **En la ejecución:** todas las técnicas del T.S. con apoyo psicológico y social.
- **En la evaluación:** sistemas de parámetros y de indicadores.

1.1.- TÉCNICAS DE CONOCIMIENTO.

1. **Técnicas de observación directa:** Observación no sistematizada, ocasional y no controlada. Nos lleva a obtener datos sobre la organización física del barrio o zona, la organización de los servicios y de cómo se configuran los grupos. La observación directa es un instrumento que proporciona al investigador la materia de trabajo que ha se ser objeto después de su tratamiento y estudio científico.
2. **Coloquios familiares:** Capta cuál es la problemática familiar prioritaria según los interlocutores que el profesional emplea en esta técnica.
3. **Técnica de encuesta:** Intenta ver y conocer situaciones, comportamientos, actitudes u opiniones.
4. **Técnicas de observación documental:** Se fundamenta en el análisis de contenido (formulación, análisis y verificación de hipótesis y variables). Por tanto, las técnicas de estudio de documentos suponen una reflexión sobre unos hechos sociales ya ocurridos y reunidos.
5. **Documentación:** Técnicas documentales, para procesar la información que se desprende de trabajo del Trabajador Social, así como su óptimo almacenamiento y diseminación.
    - **Fichero de recursos:** Sobre el tema que interviene el Trabajador Social
    - **Fichero bibliográfico:** Clasificación por autores y materias
    - **Historia Social:** Para individuos, grupos y comunidades
    - **Planes, Programas y Memoria:** Anuales o según el tiempo estipulado (con items evaluativos)
    - **Informes**
    - **Actas de reuniones**

1.2.- TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO.

A) MACRO- ACTUACIÓN: Corresponde a la planificación de servicios.

1. **Técnicas estadísticas:** Permiten analizar los datos, tanto cuantitativa como cualitativamente que se obtienen de una situación concreta.
    - **Técnicas de estadística descriptiva**
    - **Técnicas de estadística muestral**
    - **Técnicas de estadística no paramétrica**
2. **Técnicas para individualizar necesidades:**
    - **Estándares:** Comparan una situación real a un parámetro ideal.
    - **Indicadores sociales:** Medida estadística directa y válida que permite observar el nivel y las variaciones en el tiempo de una preocupación social fundamental.
    - **Análisis costo-beneficio**
    - **Observación de las patologías**

B) MICRO- ACTUACIÓN: Planificación y programación del trabajo del profesional en su barrio, municipio, zona, servicio o institución.

3. **Utilización de grilles y pautas de trabajo:** Se trata de crear un modelo para sistematizar la "interpretación de datos". Esta fase se refiere a analizar los problemas que se plantean al relacionar unas variables con otras.

Entendemos por variable los factores que influyen en los resultados y que varían en función con otros. Así la variable dependiente es aquella, cuyas variables trata de explicar el investigador, y la independiente es aquella cuya influencia en la variable se intenta medir y comprender. A su vez las variables independientes se dividen en: *Variables de posición,* constituye la características más externas y apreciables en individuos, grupos o comunidades; *Variables de posición,* es la posición que toma el individuo, grupo o comunidad frente a algo (es decir, motivación, actitud e interpretación); y *Variables de respuesta,* conducta, comportamiento o actuación del individuo, grupo o comunidad.

1.3.- TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN.

A) A NIVEL INDIVIDUAL

1. **Entrevista:** Es la técnica más utilizada por el Trabajador Social. Se puede definir como un método de investigación científica que utiliza un proceso de comunicación verbal para recoger unas informaciones en relación a una determinada finalidad.
2. **Técnicas que utilizan los recursos del medio ambiente:** Podrían ser convenientes en el caso de personas que, teniendo un comportamiento normal, deben enfrentarse a problemas de salud, socio-económicos, etc. Estos recursos pueden ser: legislación social, otros Servicios Sociales, la red social del cliente, amigos, parientes, grupos del barrio, otros profesionales, etc.
3. **Técnicas de ayuda psicológica:** Pueden estar centradas sobre el problema o sobre la propia persona.

B) A NIVEL DE GRUPO

4. **Técnicas de grupo:** Que nos sirven para información (como reducción de tensión), mejorar la comunicación y la cooperación social, descubrimiento de nuevas formas de expresión, actuar en conflictos de grupo y redistribución de poder
5. **Técnicas grupales para favorecer la creatividad:** Pueden servir para aumentar y mejorar la participación:
    - **Brainstorming:** Lluvia de ideas
    - **Phillips 6.6:** Favorece la creatividad y la colaboración. Se trata de dividir el grupo en subgrupos de 6 personas que durante 6 minutos discuten un tema y luego lo ponen en común
    - **Técnicas de comunicación:**
        - **Directas:** Técnicas de información grupal con expertos
            - **Simposio:** Un equipo de expertos desarrolla diversos aspectos de un tema o problema en forma sucesiva ante el grupo.
            - **Mesa redonda:** Un equipo de expertos que tienen puntos de vista contradictorios sobre un mismo tema exponen ante el grupo de forma sucesiva.
            - **Panel:** Un equipo de expertos discute un tema en forma de diálogo o conversación ante el grupo. Los expertos no exponen, sino que dialogan (debaten entre sí el tema propuesto).
            - **Entrevista o consulta pública:** Un experto es interrogado por un miembro del grupo, ante el auditorio, sobre un tema prefijado.
        - **Directas:** Técnicas de información en las que interviene todo el grupo.
            - **Debate dirigido o discusión guiada:** Tratar temas en discusión informal con la ayuda activa y estimulante de un conductor.
            - **Phillips 6.6**
            - **Foro:** El grupo discute informalmente, un tema o problema, conducido por un coordinador.
            - **Role- Playing:** Desempeño de roles.
        - **Indirectas:**
            - **A nivel individual: Informe Social, Ficha Social…**
            - **A Nivel grupal/social: Publicación de estudios, presentación de proyectos…**

C) A NIVEL DE COMUNIDAD

6. **Técnica de Animación Social:** Aulas de cultura, educación permanente de adultos, etc.
7. **Técnica terapéutica:** Con grupos especiales

D) A NIVEL DE MEJORA DEL PROPIO TRABAJO

8. **Técnicas de apoyo para los profesionales:** Formación permanente del Trabajador Social
9. **Técnicas de grupo:** Grupos de orientación psicoanalítica para reducir tensiones y bloqueos producidos por situaciones agobiantes.
10. **Técnicas de documentación:** Nociones de técnicas documentales.

1.4.- TÉCNICAS DE EVALUACIÓN.

La evaluación en T.S. es muy compleja, ya que hay una cantidad enorme de variables que condicionan las situaciones en las que se actúa. Para evaluar tenemos que poder controlar los resultados a través de:

1. **Sistema de indicadores:**
    - **Indicadores de medios,** que nos permitan ver cómo hemos aplicado las técnicas o como hemos trabajado para alcanzar los objetivos previstos. Como indicadores de medios tendríamos la evaluación de la estructura del sistema expresado por los recursos disponibles y por la organización de los mismos (personal disponible, equipos, instalaciones, recursos financieros) contrastados con modelos previamente elaborados.
    - **Indicadores de resultados,** que nos permitan medirlos o valorarlos. Los indicadores de resultados vienen determinados a partir del grado de satisfacción e insatisfacción de los asistidos; obteniendo por controles de seguimiento, reguladores y de la solución que se ha llegado la evaluación del resultado propiamente dicho de la intervención del profesional.
2. **Técnicas de grupo**
3. **Sistema de parámetros:** Constantes invariables que corresponden a una situación determinada y que sirven para precisar su valoración, ya sea cualitativa o cuantitativa. Se trata de hacer un patrón ideal, que nos pueda servir para evaluar luego si se ha seguido o no y qué resultados ha dado.
4. **Monitorización y seguimiento de programas**
5. **Sociometría**
6. **De contenido de temas y objetivos**
7. **De participación individual**
8. **Valoración de los imputs- esfuerzo**
9. **Valoración de los outputs- resultados**
10. **Valoración de la eficiencia (costos de los resultados)**
11. **Hoja estadística de registro de actividades**
12. **Memorias**
13. **Informes periódicos finales**
14. **Análisis de documentación profesional**
15. **Diario de campo**
16. **Cuestionario de opinión**
17. **Observación estructurada**
18. **Observación participante**
19. **Entrevista**

2.- INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS EN TRABAJO SOCIAL.

Durante estos últimos años se ha acentuado la necesidad de recalcar la importancia que tiene en el desempeño profesional la elaboración y mantenimiento de la **documentación específica** utilizada por el Trabajo Social.

A pesar de que los Servicios Sociales han promovido la informatización de la documentación, logrando que profesionales y ciudadanos disfruten de las aportaciones de las nuevas tecnologías, no es suficiente la recogida de la información que permiten los instrumentos cuantitativos. La Historia Social ofrece una gran riqueza de información, que podrá ser aprovechada en la elaboración de posteriores estudios e investigaciones. Las nuevas tecnologías nos simplifican la gestión, los procedimientos …, pero no alteran la metodología de la obtención de la información.

Los profesionales del Trabajo Social, especialmente en el desempeño de las diferentes funciones en ámbitos institucionales, necesitamos de **soportes documentales** para sistematizar, organizar y gestionar adecuadamente la información que manejamos, tanto desde el punto de vista técnico como ético.

El tratamiento de la información debe cumplir los requisitos de eficacia y eficiencia, de modo que su utilidad revierta en los usuarios del servicio, en la propia institución y en los profesionales implicados en los procesos de intervención.

El expediente nos ayuda a ordenar, recuperar y sistematizar la información referida a un usuario o unidad de convivencia, o de una familia. Se concreta en una carpeta de archivo donde se recogen y custodian todos los datos de la realidad atendida. Es la recopilación de todos los instrumentos con informaciones, tanto básicas como complementarias, correspondientes a la persona usuaria del servicio y a su entorno sociofamiliar, convivencial, vecinal, cultural, económico, laboral, institucional … El expediente no es exclusivo de los trabajadores sociales, ya que otros técnicos del equipo –psicólogos, educadores …- contribuyen a su construcción, sistematización, consulta y valoración.

El expediente debe estar integrado, fundamentalmente, por la **ficha social**, la **historia social**, el **registro de entrevistas**, la **hoja-plantilla de segumiento**, las **escalas de valoración social,** el **proyecto de intervención social,** el **genograma**, el **ecomapa**, los **informes sociales, psicológicos, médicos** … Aunque son muchas las instituciones que mantienen los expedientes en soporte papel, cada vez es más frecuente hacerlo en soporte informático.

Es fundamental la definición de cada uno de estos instrumentos que encontramos en el **Preámbulo del Código Deontológico del Trabajo Social (2.012).** Para desarrollar sus funciones, los profesionales del trabajo social cuentan con unos **instrumentos específicos del trabajo social**:

Historia social.	Documento en el que se registran exhaustivamente los datos personales, familiares, sanitarios, de vivienda, económicos, laborales, educativos y cualesquiera otros significativos de la situación socio-familiar de una persona usuaria, la demanda, el diagnóstico y subsiguiente intervención y la evolución de tal situación.
Ficha social.	Soporte documental de trabajo social, en el que se registra la información sistematizable de la historia social.
Informe social.	Dictamen técnico que sirve de instrumento documental que elabora y firma con carácter exclusivo el profesional del trabajo social. Su contenido se deriva del estudio, a través de la observación y la entrevista, donde queda reflejada en síntesis la situación objeto, valoración, un dictamen técnico y una propuesta de intervención profesional.
Escalas de valoración social.	Instrumento científico que sirve para identificar situaciones sociales en un momento dado. Permite elaborar un diagnóstico social.
Proyecto de intervención social.	Diseño de intervención social que comprende una evaluación-diagnóstico de la situación y personas con quienes actuar, una determinación de objetivos operativos, actividades y tareas, utilización de recursos, temporalización y criterios de evaluación.

2.1.- FICHA SOCIAL.

Desde el punto de vista del caso individual y del núcleo familiar, la ficha social es el documento primario en el que se registran los datos de identificación del usuario, de la demanda presentada y del recurso aplicado.

Su uso permite:

- Conocer el perfil sociodemográfico de la población que acude a los servicios sociales.
- Detectar los problemas presentados y detectar la ausencia de problemas.
- Señalar los recursos principales utilizados.
- Detectar los recursos sociales demandados y de éstos aquéllos no disponibles.
- Ser fuente primordial de información de la actividad efectuada en la intervención del profesional.

Respecto a las fichas sociales hay que hacer mención a dos cuestiones:

a) Una ficha social nunca puede ni debe suplantar a las técnicas y los resultados de la investigación social de carácter marco: censos de población, estudios de necesidad, etc.

La ficha proporciona, en sentido estricto, la información referida a los ciudadanos que han acudido a los servicios sociales. Es la demanda expresada por la población usuaria, no la demanda real o potencial de la zona. La Ficha social complementa a las técnicas macro de investigación social, Es un documento que refleja los resultados de la actuación profesional.

b) La segunda cuestión, radica en la necesidad de elaborar fichas sociales adecuadas y adaptadas a cada tipo de trabajo.

En el Ayuntamiento de Madrid, la Ficha Social adquiere el nombre y la forma de Ficha de Usuario de Primera Atención (FUPA) que rellena la Unidad de Primera Atención del Centro de Servicios Sociales.

FICHA DE USUARIO DE PRIMERA ATENCIÓN: Es el documento que recoge la demanda y la atención prestada de toda aquella persona que acude por primera vez a los Servicios Sociales, asimismo recoge los datos de identificación del usuario. Sistemáticamente se compone de:

1.- Datos del Usuario/Titular:

- Apellidos
- Nombre
- Sexo
- DNI
- Domicilio
- Nacionalidad

-Colectivo (No aplicable, Inmigrantes, Drogodependientes, Enfermos Mentales, Minusválidos, Personas sin Hogar)

2.- Otros Datos:

Debe señalarse si se trata de un caso nuevo o no; y si se trata de una urgencia de qué tipo de urgencia se trata (malos tratos, abandono, alojamiento/vivienda, desprotección social por problemas de salud, desprotección socio-familiar derivada de Emergencias-incendios, explosiones etc.) y su procedencia (por propia iniciativa, derivación del sistema sanitario, derivación del Samur Social, otros sistemas de atención de emergencias como Bomberos o Policía, detectada por el propio profesional de Primera Atención).

3.-Síntesis de Intervención con el Usuario:

- Entrevista, debe señalarse si se realiza en el domicilio o en el despacho, la fecha en que tiene lugar y su duración. (Posibilidad de realizar hasta un máximo de 3 entrevistas)
- Texto Descriptivo Breve: En el que se relata de forma resumida lo más relevante del caso.
- Demanda Realizada, y Atención Prestada (que se reflejan mediante una serie de códigos).

4.- Cierre del Caso en Primera Atención:

Que puede ser por resolución de la demanda en primera atención, por derivación a zona, por abandono y por resolución de la demanda con orientación a otros Sistemas de Protección Social.

- En la ficha debe además reflejarse los datos del trabajador social que atiende el caso, el número de expediente en primera atención y el de Historia Social en su caso.

Ficha de Identificación.

Es un documento en el cual se consignan los datos de identificación personal del usuario, y al que se concede un número también de identificación. Su finalidad es la localización de cualquier expediente familiar o global.

El modelo de esta ficha consta de las siguientes partes:

- N° de ficha y del expediente
- Datos personales del usuario/cliente
- Demanda planteada
- Observaciones

2.2.- INFORME SOCIAL.

El **Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales** define el informe social como "la síntesis explicativa de una situación dada, emitida por un trabajador social como resultado del estudio, valoración y dictamen, para el logro de un objetivo determinado".

El Informe Social pretende, por tanto:

1. Dar a conocer la existencia y características de una situación social determinada con el propósito de paliarla o modificarla.
2. Aportar información para el dictamen profesional.
3. Obtener recursos sociales ya establecidos.
4. Promover recursos sociales.
5. Facilitar información a otro trabajador social.

Ezequiel Ander-Egg lo define como "documento que facilita datos e información referentes a la situación de personas, instituciones, grupos, problemas o hechos, consignando la interpretación, opinión o juicio del trabajador social que lo emite".

Un autor español clásico, como **Manuel Moix**, lo define como "documento elaborado por el trabajador social en el que consta, en síntesis, no solo el resultado del estudio o valoración de la situación del cliente, sino también el consiguiente dictamen y la oportuna propuesta de actuación profesional".

La elaboración de este documento requiere un proceso de selección de los datos registrados en la historia social y sistematizados en la ficha social. La confección del informe, por tanto, se produce con posterioridad a determinadas intervenciones profesionales y es el resultado de tratar de ordenar la información recabada, realizando un **proceso racional de interpretación que conduce a la emisión de un juicio profesional.**

Son rasgos, por tanto, del informe social:

- La obligatoriedad de que el informe social solo puede ser efectuado por los diplomados en Trabajo Social / Asistentes Sociales, según se establece en el Código Deontológico.
- Es un **dictamen técnico** soportado en base documental que sirve como instrumento a los profesionales del Trabajo Social.

- Es una **técnica profesional** al configurarse como un dictamen técnico que es emitido conforme a criterios técnico-científicos que poseen los trabajadores sociales.
- Es el **resultado de una intervención**, con una estructura que se recoge dentro de un marco general para su elaboración.
- Tiene una finalidad: **informar de la situación** de una persona o familia desde los criterios técnicos del Trabajo Social.
- Incluye una **valoración** y una **propuesta de intervención** a otra entidad, aunque este último apartado se puede obviar si no es ese el objeto del informe.

A diferencia de la historia social, que es una, puede haber tantos informes sociales como sean necesarios para el tratamiento y resolución del caso.

La variedad de los informes que podemos realizar nos permite diferenciar entre diversos tipos de informes.

- **Informes técnicos:** no son estrictamente un informe social, ya que no reflejan la totalidad de la situación y no presentan la estructura básica de un informe social. Su objetivo está más relacionado con la solicitud o modificación de prestaciones, por ejemplo, una residencia para personas discapacitadas. En la mayoría de las prestaciones regladas las instituciones tienen sus propios modelos, recogiendo estos informes específicos.
- **Informes acreditativos:** se realizan atendiendo a un convenio entre entidades. Sirve para acreditar que una situación es cierta, para la obtención de un determinado servicio o prestación.
- **Informes de derivación o propuesta:** su objetivo es derivar al usuario o a la familia a un determinado programa o servicio.
- **Informes sociales genéricos:** el contenido de la información puede proporcionar información sobre varias situaciones, desde una solicitud de una vivienda, la concesión de una prestación o la solicitud de información por parte del propio usuario.
- **Informes sociales sobre menores:** los informes de menores en los que se proponen medidas de protección son de especial significado, debido a las consecuencias que se pueden derivar de esta propuesta.
- **Informes sociales de mayores o personas adultas en riesgo:** cada vez es más frecuente la solicitud de informes sociales en este ámbito. Su trascendencia es muy parecida a los informes ya citados en relación a los menores.

Los datos que se aportan en un informe social deben ser los adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad que se pretende, evitando incorporar toda la información con la que se cuenta, obtenida fundamentalmente a través de la observación y la entrevista, y que no sea relevante al objetivo para el que se emite el informe.

Si bien es importante el contenido del informe, la presentación contribuye decisivamente a la forma en que es percibido por el destinatario y, en definitiva, a su utilidad. El informe ha de ser **estructurado**, es decir, guiado por una secuencia lógica que interrelacione todos los aspectos parciales que integran la narración. La estructura en apartados del informe permite romper la monotonía del texto y evitar el desorden entre las ideas. Si el informe carece de secuencia lógica se dificulta su comprensión y desmotiva a su lectura.

El informe social está muy delimitado por el ámbito de intervención de la institución donde se encuentra trabajando el profesional que lo emite, motivo por el cual, aunque el contenido varíe en función del caso, el objetivo y el estilo descriptivo del profesional, la **estructura** siempre debe ser la misma, que es la que caracteriza a la institución.

En cuanto al **objetivo del informe**, la información a aportar es distinta entre los diferentes tipos de informe. El contenido de un informe para plantear medidas de protección de un menor es diferente a un informe de seguimiento de un acogimiento o un informe de derivación para un recurso de mayores.

ESTRUCTURA DEL INFORME SOCIAL.
1.- Datos de referencia o cabecera.
Estos datos identifican la institución y el profesional que emite el informe. Deben ser escuetos y explicativos, añadiendo también el motivo del informe y a quien se dirige. El deber de identificación del profesional viene recogido en la Ley 39/2.015. Además de la identificación del profesional se debe especificar la unidad de trabajo dentro del servicio.
2.- Datos de identificación de la unidad de convivencia.
Describe el núcleo de convivencia de la familia o persona objeto del informe. Es necesario recoger el nombre y apellidos de todos los miembros de la unidad familiar, además de otros datos necesarios para el profesional o entidad que recibe el informe: fecha de nacimiento, DNI, domicilio actual y teléfono. En algunos casos es necesario incorporar a personas que aunque no forman parte de la unidad familiar, entendida ésta como el núcleo de convivencia, pero son relevantes en la intervención, identificando si tienen grado de parentesco o no con la familia o persona sobre la que se informa. En ocasiones, cuando la descripción de la unidad familiar es relevante para la intervención, y por lo tanto se precisa aportar información sobre ella, se puede aportar el **genograma**. El genograma es una estructura gráfica que permite dibujar un "árbol genealógico" registrando la información significativa sobre los miembros de la familia y sus relaciones. El genograma permite mostrar de una forma rápida de la información familiar y los patrones familiares establecidos, sobre todo los referidos a los vínculos y a la consanguinidad.
3.- Fuentes para la obtención de información.
En este apartado reflejamos, de forma ordenada, el grado de intensidad de la intervención, el tiempo durante el cual se ha producido y los distintos servicios que han intervenido.
4.- Antecedentes del caso.
En este apartado recogemos la fase de inicio del proceso de intervención con la familia. Es determinante conocer si la demanda fue a iniciativa del usuario o bien a demanda del profesional, qué situación originó la intervención, con qué recursos complementarios se ha contado, objetivos planteados … Este apartado plantea que para la elaboración del informe social hay que contar con otros documentos técnicos que ha utilizado el profesional: historia social, proyecto o diseño de intervención, hojas de seguimiento o de incidencias que recogen las entrevistas y coordinaciones mantenidas … En este apartado vamos a hacer referencia a los distintos momentos por los que ha pasado el usuario o la familia a lo largo de la intervención: cómo ha evolucionado, los altibajos en la intervención, el uso adecuado o inadecuado de los recursos aplicados …

5.- Situación actual.

Este apartado es el núcleo del informe, donde se describe la situación que lo origina. Hay que recoger todas las variables que influyen, tanto en la intervención, como en la situación problema. Es imprescindible no confundir este apartado con los antecedentes del caso.

En este apartado se describen y analizan todas las áreas que se van a abordar en el plan de trabajo que se está realizando o ya se ha realizado, en función del objetivo del informe.

Las **áreas de trabajo** que se pueden plantear son muy amplias y heterogéneas: características del núcleo de convivencia o situación sociofamiliar, situación económica y laboral, situación escolar y cultural, situación de salud, datos de la vivienda y de la zona de residencia …

6.- Intervención social realizada.

La descripción de la intervención no debe recoger la enumeración de las actuaciones realizadas –que ya hemos señalado en un apartado anterior-. Se trata de realizar una descripción de las diferentes hipótesis sobre las que hemos trabajado y como las hemos ido consensuando con el usuario o la familia, así como las medidas que hemos puesto en marcha y los objetivos que tratábamos de conseguir a través de la intervención.

7.- Diagnóstico social.

El diagnóstico o **valoración social** es el resultado de ordenar las distintas variables que hemos analizado a lo largo de todo el proceso. Para su elaboración utilizamos todos los instrumentos técnicos de los que disponemos: diseño de intervención social, historia social, hojas de seguimiento, observación, entrevistas, informes de otros profesionales …, que nos van a transmitir el resultado de las actuaciones realizadas.

En el diagnóstico debemos identificar el problema y la necesidad de la persona o familia sobre la que realizamos el informe, responder al porqué de estas necesidades y hacer referencia a las acciones que la familia y la institución o el profesional han llevado a cabo. También determinaremos las prioridades de la intervención y estableceremos las estrategias para llevarlas a cabo.

El diagnóstico no debe redactarse con conceptos genéricos que informen de dificultades generales, sino que debe tender a describir la situación de la persona o la familia con la mayor claridad posible, destacando tanto los aspectos negativos, como los aspectos positivos.

8.- Propuesta de intervención.

En este último apartado describiremos las medidas a aplicar a juicio del profesional y del servicio emisor, acciones a llevar a cabo y recursos a poner en marcha, así como los beneficios que puede conllevar la propuesta realizada o los inconvenientes de no desarrollarla.

9.- Firma.

El informe social debe ir debidamente firmado por el profesional o profesionales que lo han realizado, especificando la unidad de trabajo a la que pertenecen, siendo conveniente incorporar el número de colegiado.[1]

[1] La Ley de Colegios Profesionales dispone que *"Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al Colegio correspondiente".*
La Ley 10/1.982, de creación de los colegios oficiales de Asistentes Sociales establece que *"Los Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, que podrán tener el ámbito de Comunidades Autónomas, regional o provincial, integrarán en sus respectivos territorios a quienes reúnan los requisitos legales para ser considerados como Diplomados universitarios en Trabajo Social y Asistentes Sociales, siendo obligatoria para el ejercicio de la profesión la incorporación al Colegio correspondiente".*

2.3.- HISTORIA SOCIAL.

De los tres documentos básicos del Trabajo Social –la Ficha Social, la Historia Social y el Informe Social-, hay que destacar el papel central de la **Historia Social**, siendo ésta el principal soporte documental:

- En la **Ficha Social** se encuentran los datos básicos de la Historia Social que han sido extraídos, ordenados y normalizados para poder ser incorporados a los diferentes bancos de datos informatizados.
- El **Informe Social** recoge parte de los datos descriptivos de la Historia para poder informar a terceros sobre las necesidades planteadas y sus posibles respuestas. Podemos decir que es un informe realizado con el diagnóstico de la situación elaborado tras la reflexión sobre el contenido de la Historia Social.

La historia social es el primer documento utilizado por los trabajadores sociales desde una perspectiva histórica. Corresponde a **Mary Richmond** la propuesta de sistematizar el conocimiento de las personas con las que se intervenía y la confección de la historia social, haciendo dicho conocimiento más científico y eficaz. La historia social recogería, por tanto, no solo las características de la persona, sino también su entorno social y cultural

La historia social es una narración descriptiva y explicativa de la evolución experimentada por la unidad de análisis. Es el documento más básico e importante del expediente y facilita la comprensión de la trayectoria de la persona o familia con la que se trabaja, tanto en el momento actual, como en el futuro, a los trabajadores sociales que puedan hacerse cargo.

La historia debe actualizarse periódicamente para que no pierda su utilidad.

La historia social es una síntesis del pasado y del presente más inmediato.

- Se apoya en los documentos primarios (declaraciones, registros de entrevista, historias de vida elaboradas por los propios afectados …).

El fundamento metodológico de la Historia Social lo vamos a encontrar en el **método biográfico**, de amplio uso en las ciencias sociales, de forma más concreta en las llamadas "historias de vida". El ejemplo más significativo del uso del método biográfico en la sociología lo tenemos en los trabajos de Thomas y Znaniecki en 1.920 sobre "el campesino polaco en Europa y América". Estos autores van a ser los primeros en analizar el entramado de relaciones que vincula la estructura social y el carácter individual. La diferencia entre historia social e historia de vida hay que buscarla en la finalidad de cada una de ellas. La "historia de vida" es el relato autobiográfico obtenido por el investigador mediante entrevistas sucesivas, en las que el objetivo es mostrar el testimonio subjetivo de una persona, en la que se recogen tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia.

El Trabajo Social tiene la vocación de intervención para modificar la realidad, lo que implica que el trabajador social confecciona su historia para realizar un diagnóstico de la situación y proceder a aplicar medidas correctoras. No hay que olvidar, por tanto, que el objetivo fundamental de la Historia Social es la **intervención social.**

La historia social no es una mera descripción o enumeración de datos, agrupados de forma acumulativa, sino un guion con sentido en el que se interrelacionan variables y se explica la vida o parte de ella de una persona, una familia, una comunidad o una organización. Es **un documento en el que se recogen los datos de forma diacrónica o histórica de la situación de la unidad de análisis (usuario y entorno).**

En la confección de la historia social se deben tener en cuenta las **técnicas** de:

- La entrevista.
- La observación.
- La recopilación y el registro de la información.

La historia social pretende conseguir dos tipos de **objetivos**.

- **A corto plazo**: Permite conocer todos los hechos, sucesos y episodios importantes en la vida de una persona o familia, tanto pasados como presentes y que influyen en las circunstancias actuales y permite la explicación de toda esta información.
- **A largo plazo:** Nos sirve para elaborar el diagnóstico social, plantear o promover posibles actuaciones, facilitar el seguimiento personal del cliente, permitir a otros profesionales conocer la valoración de su problemática concreta, y extraer los elementos necesarios para realizar los informes sociales que aconsejen el tratamiento a seguir.

La historia social recoge las raíces recoge las raíces humanistas del Trabajo Social. La ficha social y el informe social describen la vivienda actual, situación, dimensiones, existencia o no de barreras arquitectónicas, … La historia social, en cambio, reflejará las viviendas anteriores, el grado de satisfacción con la vivienda actual, así como las causas por las que viven en ella.

Este soporte documental permite un registro literal de las circunstancias y vivencias de los usuarios, tal como lo cuentan, con sus expresiones literales, rasgos culturales u otros matices que se pueden perder al sistematizar los datos estrictos en el lenguaje técnico exigido por la ficha o el informe social.

Los temas en torno a los cuales se articula la historia social son:

- Datos de identificación del cliente.
- Composición familiar.
- Trayectoria educativa.
- Datos sanitarios.
- Evolución económica y laboral.
- Tipo de vivienda.
- Características del barrio.
- Relaciones familiares y sociales.
- Asociacionismo …

Consta de los siguientes **apartados:**

Encabezamiento: Número de Expediente y Código postal.

1.- **Datos de Referencia**: Fecha de alta, distrito, domicilio, barrio, teléfono, Centro, Zona, Trabajador Social y modalidad de convivencia.

2.- **Vivienda**: tipo, régimen de tenencia, nº de habitaciones, compartida o no.

3.- **Datos del Usuario y Núcleo de Convivencia:** Apellidos y Nombre, DNI, Fecha de Nacimiento, Sexo, Estado Civil, Parentesco, Nivel de Estudios, Situación Laboral, Ocupación, Nacionalidad, Colectivo, Ingresos Mensuales.

4.- **Dinámica Familiar** (Factores más sobresalientes que caracterizan y definen al núcleo de convivencia).

5.- **Entorno Social** (Tipo de barrio, equipamientos, servicios, etc. Relaciones Sociales y Vecinales, Nivel de Participación en su entorno social, uso de servicios existentes, etc).

6.- **Valoración de los problemas**, que se codifica de acuerdo a las tablas en vigor.

7.- **Puntos fuertes**.

8.- **Valoración diagnostica**.

9.- **Demanda/ Atención Prestada**, en donde se reflejan ambas situaciones el usuario, el usuario que recibe y realiza la atención, fecha de alta en la prestación y de baja).

2.4.- ESCALAS DE VALORACIÓN SOCIAL.

Las **escalas de valoración** son un instrumento científico que sirve para identificar situaciones sociales en un momento dado, permitiendo, de una manera objetiva, elaborar un diagnóstico social.

- La **escala de Gijón** valora el sistema socio-familiar en el que se encuentra una persona. Son muy utilizados en las personas mayores.
- **Cuestionario Apgar familiar** es un cuestionario cuyo objetivo es evidenciar el estado funcional de la familia. El entrevistado coloca su opinión al respecto del funcionamiento de la familia.
- El **cuestionario de apoyo social percibido- Duke-** refiere al apoyo que percibe una persona en su vida diaria. Es importante para conocer la red social de una persona.
- La **escala de relación sociofamiliar** nos ayuda a detectar el riesgo social de un usuario.
- La **escala de sobrecarga del cuidador -Zarit-** permite conocer el grado de sobrecarga de una persona que cuida de alguien dependiente.
- **Cuestionario para detectar la violencia hacia la mujer.**

La mayoría de las escalas que se van a utilizar en el ámbito del **Trabajo Social** están relacionadas con herramientas y escalas para valorar la situación de las **personas mayores.**

Para medir la **capacidad funcional de las personas** mayores, es frecuente utilizar las escalas de **Katz, Barthel, Lawton y Brody** y otros test.

- **Índice de Katz.** Se diseñó inicialmente para pacientes ingresados y en rehabilitación. El orden de los items refleja la progresión natural en la pérdida y la recuperación de la función. Es una ordenación jerárquica (la capacidad de realizar una función, implica realizar las previas más simples).
- **Índice de Barthel.** Presenta importantes ventajas respecto al Katz: discrimina más las funciones (así distingue la movilidad en uso de escaleras, traslado sillón-cama, y deambulación; o diferencia incontinencia en la micción y deposición) y establece una puntuación total de 0 a100 puntos.
- **Índice de Lawton y Brody.** Desarrollada en el Centro Geriátrico de Filadelfia, de ahí que también sea conocida como Philadelphia Geriatric Center – Instrumental Activities of Daily Living (PGC – IADL). Fue construida específicamente para población anciana, institucionalizada o no. Detecta primeros grados de deterioro. Detecta mejor que ABVD cambios de humor y salud afectiva (un paciente con deterioro en este sentido, primero dejará de realizar funciones instrumentales).

Son también numerosos las escalas que permiten medir la **función cognitiva.** La disfunción cognitiva es un síndrome, y los cuestionarios un complemento de una valoración clínica amplia si se trata de diagnosticar un deterioro cognitivo (por sí solos nunca son diagnósticos).

- **Cuestionario de Pfeiffer.** Sus items exploran fundamentalmente orientación y memoria, aunque también elementos de autonomía en la comunidad (conocer número de teléfono), o capacidad matemática (ir restando de 3 en 3).
- **Mini Examen Cognoscitivo (MEC).** Constituye la adaptación y validación en España del Mini Mental State Examination de Folstein (MMSE)
- **IQCODE, Test del Informador (TIN).** Es específico para la detección de demencias. Lo cumplimenta un familiar o allegado en unos 5 minutos. En estadios iniciales este test es más sensible que los demás para el diagnóstico de demencia.

La **función afectiva** puede sufrir también cambios importantes en las personas mayores. Los cuadros depresivos, y sobre todo distimias, tienen elevada prevalencia en la gente mayor, aunque con frecuencia no están adecuadamente diagnosticadas. El deterioro afectivo puede simular un deterioro cognitivo (pseudodemencia). La entrevista clínica es el instrumento más útil para valorar y diagnosticar un trastorno afectivo. Las escalas nunca sustituyen una amplia valoración clínica.

- **Escala Geriátrica de Depresión (GDS) (versión reducida).** Especialmente concebida para evaluar el estado afectivo de ancianos, ya que evita un exceso de preguntas somáticas. La puede cumplimentar el paciente, o un entrevistador. No se necesita entrenamiento previo. Rápida y segura.
- **Cuestionario de Goldberg (abreviado).** Muy sencilla y breve.

Las **escalas de valoración social** suelen estar enfocadas a áreas relevantes, como son la identificación cuidador principal, las actividades sociales (profesión, aficiones, salidas fuera de domicilio, clubs sociales, actividades), las relaciones sociales (estado civil, relaciones con familiares, con vecinos y amigos, pertenencia a grupos), el soporte social (tamaño de la familia, contactos familiares, confidente, asistencia en casa) o los recursos sociales (ingresos económicos, características vivienda, seguridad, convivencia, entorno y servicios públicos)

- **Cuestionario de Función Familiar, Apgar Familiar.** Valora cinco componentes de la función familiar: Adaptability (adaptabilidad), Partnership (cooperación), Growth (desarrollo), Affection (afectividad), Resolve (capacidad resolutiva).
- **Escala sociofamiliar de Gijón.** Es uno de los instrumentos que se ha empezado a utilizar en nuestro país en la última década, ha demostrado ser útil en la detección de riesgo social y también en la problemática social ya establecida en la comunidad.

2.5.- PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.

El **proyecto de intervención social** proyecta acciones sistemáticas y fundamentadas, con un objeto definido y metas claras y factibles. Se trata de un documento complejo que incluye una evaluación-diagnóstico de la situación y personas con quienes actuar, una determinación de objetivos operativos, actividades y tareas, utilización de recursos, temporalización y criterios de evaluación.

Uno de los esquemas clásicos de proyectos de intervención social remite a la respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿QUÉ HACER?: Propuesta.
- ¿PARA QUÉ?: planteamiento del contexto y del problema.
- ¿A QUIÉNES?: personas implicadas como destinatarios.
- ¿CON QUIÉNES?: personas implicadas como responsables.
- ¿DÓNDE?: lugares y espacios en donde se realizan las actividades.
- ¿CUÁNDO?: cuadro temporal en el que se realizará.
- ¿CUÁNTO?: Etapas previstas y cantidad de actividades especificas a llevar a cabo.
- ¿CÓMO?: técnicas a usar.
- ¿CON QUÉ?: medios e instrumentos con los que contamos.
- EVALUACIÓN: Monitoreo - Evaluación Parcial - Evaluación Final.

1.- Fundamentación.

La fundamentación se puede desarrollar desde muchas **perspectivas**, desde un **enfoque profesional** -teorías o modelos que tenemos en cuenta- o desde los **principios profesionales**, señalados en el Código Deontológico, a tener en cuenta en toda intervención profesional: individualización, expresión directa de sentimientos, escucha activa, empatía, aceptación, autodeterminación, derecho a elegir libremente en la intervención, dar a conocer al usuario el proceso y las medidas planteadas …

La fundamentación también puede recoger argumentos relacionados con el **colectivo** con el que se va a trabajar o con el **enfoque legal e institucional**, leyes y planes o programas en los que apoyamos nuestra intervención.

2.- Contextualización del caso.

Se trata de situar el caso en el **contexto en el que se va a desarrollar**, partiendo de la entidad en la que vamos a plantear la intervención (Atención Social Primaria o Servicios Sociales Generales o en algún recurso de la Atención Social Especializada o Servicios Sociales Especializados). Es un apartado muy breve en el que reflejamos el conocimiento de la institución desde la que vamos a intervenir.

3.- Estudio y conocimiento del campo de actuación.

Análisis de la demanda.

La demanda es el primer instrumento que nos ofrece el usuario para acercarnos a su realidad. De esta demanda se hará eco el planteamiento del supuesto. Hay que tener en cuenta que es el primer elemento de la relación T.S.-cliente: el cliente nos informa, de manera explícita e implícita, de una situación problema. Es importante diferenciar entre las demandas explícitas y las demandas implícitas.

Hipótesis.

En las primeras entrevistas siempre nos hacemos una primera hipótesis de cuál es la situación problema. Esta hipótesis se puede ver confirmada con el diagnóstico o en ocasiones ser modificada por éste. El problema que nos encontramos en el caso práctico es que no tenemos oportunidad de contrastar la hipótesis con posteriores entrevistas.

Estudio y análisis de las variables. Identificación y jerarquización.

Trabajamos en el ámbito de los problemas o necesidades sociales. Es importante identificarlos, relacionarlos, jerarquizarlos … El análisis nos permite distinguir o diferenciar las partes de un todo para conocer sus elementos. No hay que olvidar que paralelamente a este análisis lo haremos también con los **aspectos positivos.**

4.- Valoración o diagnóstico social.

El diagnóstico persigue dos objetivos básicos: Identificar los problemas y necesidades, priorizándolos, de cara a la acción y explorar las distintas formas de abordar la acción.

El diagnóstico, por lo tanto, debe incluir:

1.- Una definición del problema.

2.- Los factores de riesgo que contribuyen a la generación o cronificación del problema.

3.- Los factores de protección que permitirían modificar la situación sobre la que vamos a intervenir.

El **pronóstico** se puede incluir como un elemento final del diagnóstico. Consiste en prever qué puede ocurrir si no se inicia la intervención. Con frecuencia el pronóstico se realiza desde una perspectiva negativa, se puede plantear "en positivo", qué va a ocurrir si se inicia la intervención.

5.- El proceso de ejecución.

El proceso de ejecución consiste en describir y ordenar temporalmente el conjunto de actuaciones y actividades necesarias para movilizar los recursos, para aplicar los tratamientos o para desarrollar las actividades que hagan efectiva la intervención prevista.

Objetivos generales.

Toda intervención es un proceso guiado por unos objetivos para poder llegar a los fines propuestos en la intervención. El final de todo el proceso es el objetivo general. Este objetivo general hay que concretarlo a través de los objetivos específicos.

Los **objetivos generales s**uponen la descripción objetiva y concisa de que se pretende alcanzar con la intervención que se está planeando o ejecutando. Precisan la finalidad de la intervención en sus expectativas más amplias, orientan toda la intervención.

Objetivos específicos.

El objetivo específico detalla, desglosa y define con mayor precisión las metas que se pretenden alcanzar. Deben ser formulados en términos operativos, incorporando las variables o indicadores que se deben medir.

Los objetivos tienen que reunir las siguientes características:

- Deben estar redactados con claridad.
- Deben comenzar con un verbo en infinitivo.
- Deben ser alcanzables.
- Deben contener, además de la actividad, una finalidad.
- Deben estar dirigidos a la obtención de resultados.
- Cada objetivo debe aludir a un logro.

Actuaciones y temporalización.

En la fase de las actuaciones vamos definir de forma más específica el quehacer profesional, el proceso de intervención social llevado a cabo.

Las actuaciones son consensuadas en todo momento con la familia y atenderán en todo momento al desarrollo de sus propios recursos personales, fomentando procesos de crecimiento y de autonomía.

Las actuaciones se pueden estructurar en tres fases:

- **A corto plazo:** son las actuaciones que se realizan al comienzo de la intervención y que dependen, en cierta medida, de las características del caso a resolver y del nivel de urgencia que requieran determinadas situaciones. Se tratan de los primeros acompañamientos que se realizan con el usuario.
- **A medio plazo:** es fundamental el seguimiento de la situación, entendiendo por seguimiento no solo el de las prestaciones asignadas, sino todas las actividades profesionales que vamos a desarrollar dentro del proceso de acompañamiento, en el que el individuo y el profesional –no las prestaciones- son los recursos principales.
- **A largo plazo:** la intensidad de la intervención va disminuyendo. Se espacian las entrevistas y se potencia la autonomía del usuario/familia, reforzándola respecto a la consecución de los objetivos marcados para el proceso de intervención.

6.- Metodología de la intervención.

El Trabajo Social se define por estar en una realidad en continuo proceso de cambio, con lo cual está continuamente redefiniéndose. Es, por tanto, imposible, plantear una metodología de intervención rígida.

Intervenimos fundamentalmente para transformar, activar, potenciar, movilizar … Estos procesos no podemos lograrlos sin la participación de las personas con las que estamos interviniendo. La metodología debe estar siempre basada en el consenso, la construcción conjunta, la flexibilidad, el respeto hacia el cliente …

Es importante hacer referencia a un método participativo, basado en el respeto, la coordinación con otros profesionales y recursos, la potenciación de la autonomía y la prevención de la cronificación de los problemas.

7.- Técnicas.

Las técnicas en Trabajo Social tratan de generar o mejorar las capacidades y habilidades para que las personas puedan analizar su realidad social y situarse adecuadamente frente a las diferentes opciones que se les presentan.

Es necesario hacer referencia a las técnicas instrumentales que apoyan la intervención: instrumentos para la recogida de datos, para la programación y para la evaluación.

Podemos diferenciar entre:

- Las técnicas de relación profesional, basadas en la individualización, la expresión explícita, la aceptación, la actitud exenta de juicios o el secreto profesional.
- La observación directa e indirecta.
- Las técnicas documentales: informe social, diseño de intervención social, la historia social, las hojas de seguimiento.
- La gestión de los recursos.
- Las técnicas propias de la entidad: programas informáticos, nuevos soportes documentales …

8.- Los recursos.

Los recursos son los elementos necesarios para conseguir los fines de la intervención. Podemos diferenciar entre los recursos humanos, materiales, técnicos, financieros e institucionales. Responden a la pregunta "¿con que contamos?".

- Los recursos humanos son los principales elementos en los procesos de intervención social. En la intervención individual, lo es la persona/familia y, en segundo plano, los profesionales intervinientes.
- Los recursos materiales se pueden diferenciar en tangibles –se gastan durante el proceso- e intangibles.
- Entre los recursos económicos podemos señalar las pensiones, rentas mínimas, becas de comedor, las prestaciones establecidas en el PIA …
- Los recursos técnicos hacen referencia a las técnicas e instrumentos utilizados.
- Los recursos institucionales son las instituciones que van a intervenir durante la intervención.

9.- Evaluación.

En la intervención social la evaluación no es la etapa final del proceso, sino que va a estar presenta de forma continuada, permitiendo corregir las posibles desviaciones que se produzcan en relación al cumplimiento de los objetivos propuestos. Este proceso de evaluación debe estar centrado en la calidad de la atención al ciudadano, contando con su participación continuada, permitiendo crear espacios de solidaridad y desarrollo dentro del entorno comunitario.

En el Ayuntamiento de Madrid este documento se recoge como **"Diseño de Intervención Social" (DIS).**

Es el documento en el que se plasma junto con el usuario y/o la familia la intervención a realizar, los objetivos y el tiempo para su consecución, sistemáticamente consta de las siguientes partes:

1. Demandas/Problemas que motivan la intervención (Priorizados)
2. Puntos Fuertes
3. Valoración Diagnóstica
4. Objetivos Marcos de la Intervención (prevención, modificación y contención, marcados según el orden que valore cada profesional con relación al caso)

   4.1. Objetivos Específicos
5. Plazo de Consecución de los Objetivos
6. Intervención Profesional (entrevistas, visitas domiciliarias etc.)

- Frecuencia Entrevistas (menos de un mes, mensual, bimensual, trimestral o semestral).

7. Recursos y Prestaciones a utilizar
8. Indicadores de Evaluación (resultados esperados)

El DIS tiene posibilidad de cuatro revisiones que se realizan cada seis meses, señalándose al finalizar cada intervención si continúa o no la intervención y la fecha prevista para la próxima revisión.

Al finalizar la intervención hay que señalar:

- Los problemas sobre los que se ha intervenido

- La evaluación de 1a Intervención

- Los motivos de la finalización (consecución de los objetivos, no aceptación de la intervención, abandono, derivación a otros sistemas de protección social, otros)

- Observaciones



.- **TRIGUEROS GUARDIOLA, Isabel**.- Manual de Prácticas de Trabajo Social Comunitario en el Movimiento Ciudadano, Siglo XXI, Madrid, 1991.

.- **VV.AA**.- Manual de Técnicas utilizadas en Trabajo Social, E.U.T.S. de San Sebastián, Universidad del País Vasco, Donostia, 1986.

.- **FONT, Teresa y PORCEL, Amparo.**- Materiales de Trabajo Social II- Estudio sobre Técnicas de Trabajo Social, Colegio Oficial de D.T.S. y AA.SS. de Cataluña, 1986.

.- **ANDER- EGG, Ezequiel**.- Diccionario de Trabajo Social, Novaterra, Barcelona, 1987.

.- **ESCARTÍN CAPARROS, María José**.- Manual de Trabajo Social. Modelos de Práctica Profesional, Aguaclara, Alicante, 1992.

.- **CORRAL, Lucía y otros**.- Técnicas básicas de planificación y programación, Consejo General de Colegios Oficiales de D.T.S. y AA.SS. de España.